

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Сыпь у беременных

Дифференциальная диагностика зудящих дерматозов беременности:
от безобидных до неотложных

Физиологические и патологические дерматозы беременности, дифференциальная
диагностика с инфекционными сыпями.

Один вызов: зудящая сыпь на животе у беременной 33 недель с единственным эпизодом
лихорадки.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 28 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Сыпь у беременной

“Беременная, 27 лет, первая беременность, срок 33 недели. На животе сыпь, мелкие красные пятна, не возвышаются над кожей. При диаскопии элементы бледнеют неотчётливо, но они и так не яркие, как-то сомнительно. Сыпь зудит, пациентка отмечает усиление зуда в вечернее время. Сыпи нет на других участках тела, на конечностях, спине, лице. На животе — растяжки (striae gravidarum). Слизистые без изменений. Было однократное повышение температуры до 38 °С. Спала сама, без жаропонижающих.

При осмотре пациентка активная, самочувствие удовлетворительное. Температура 36,8 °С, АД 118/75 мм рт. ст., ЧСС 88 в минуту, ЧД 16 в минуту, SpO₂ 99 %. Окружность живота и высота стояния дна матки соответствуют сроку беременности, живот мягкий, безболезненный. Шевеления плода чувствуются, сердцебиение плода 140 в минуту.

Акушерской патологии вроде нет, в инфекционном плане не уверен, но подъём температуры зафиксирован, поэтому ехать ей в инфекционку.

В итоге пациентка категорически отказывается от госпитализации в инфекционный стационар и остается дома.”

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Какой первый вопрос относительно сыпи, который нужно задать до начала дифференциальной диагностики?
2. Почему сыпь на животе у беременной требует особого внимания и какие состояния нужно исключить в первую очередь?
3. PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy) — что это, каковы типичные сроки возникновения, локализация и прогноз?
4. Пемфигиоид беременных (pemphigoid gestationis) — чем отличается от PUPPP, какие опасности для матери и плода?
5. Псориаз при беременности — как изменяется течение болезни, какие особенности локализации и чем отличается от других дерматозов?
6. Внутривенный холестаз беременных — почему это включается в дифференциальный диагноз при зуде без видимой сыпи?
7. Как инфекционные сыпи отличить от дерматозов беременности на догоспитальном этапе?
8. Что делать при отказе от госпитализации и какие критерии требуют обязательной госпитализации?

Общие положения

Дерматозы беременности встречаются у 20–40 % беременных и варьируют от физиологических изменений до состояний, угрожающих жизни матери и плода. Большинство дерматозов беременности специфичны для гестационного периода и патогенетически связаны с гормональными и иммунологическими изменениями.

Ключевое различие в дифференциальной диагностике — разграничение зудящих дерматозов беременности и инфекционных сыпей. Зудящие дерматозы беременности характеризуются преимущественной локализацией на животе, отсутствием системных признаков инфекции и закономерными сроками возникновения. Инфекционные сыпи при

беременности требуют немедленной оценки и исключения в связи с потенциальным риском для плода (ветряная оспа, краснуха, другие вирусные экзантемы).

Задача догоспитального этапа заключается не в постановке точного нозологического диагноза дерматоза, а в исключении инфекционной природы сыпи и оценке риска для матери и плода.

Классификация дерматозов беременности

Физиологические изменения

- **Гиперпигментация** — потемнение ареол, linea nigra, мелазма (хлоазма)
- **Striae gravidarum** (растяжки) — типичны для III триместра, локализуются на животе, бёдрах, груди
- **Васкулярные изменения** — паутинные ангиомы, пальмарная эритема
- **Увеличение сальных и потовых желёз** — может усиливать акне

Эти изменения не требуют лечения и не влияют на исход беременности.

Специфические дерматозы беременности

Дерматоз	Срок возникновения	Локализация	Характер сыпи	Зуд	Прогноз
PUPPP (полиморфная сыпь беременных)	III триместр, чаще primigravida	Живот, особенно в области растяжек	Уртикарии, папулы, бляшки	Есть	Благоприятный, проходит после родов
Пемфигоид беременных	II–III триместр, может начаться раньше	Живот, распространяется на всё тело	Пузыри, везикулы, эритема	Сильный	Риск для плода, требует наблюдения
Внутрипечёночный холестаз	III триместр	Нет сыпи или слабо выраженные эксфолиации	Обычно нет сыпи	Сильный зуд	Риск для плода, требует лечения
Псориаз	Любой триместр (может обостряться)	Локти, колени, волосистая часть головы, поясница	Эритематозные бляшки с чешуйками	Может быть	Обычно благоприятный, тяжёлые формы — риск для плода
Атопическая сыпь беременных	Любой триместр	Любая локализация	Экземоподобная сыпь	Есть	Благоприятный

Основные дерматозы беременности

PUPPP — полиморфная сыпь беременных (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy)

Наиболее частый специфический дерматоз беременности; распространённость составляет 1 : 150–300 беременных.

- **Срок возникновения:** III триместр, преимущественно у primigravida (первая беременность); возможно начало в раннем послеродовом периоде
- **Локализация:** дебют в области растяжек передней брюшной стенки с последующим распространением на бёдра, ягодицы, реже — на верхние конечности; лицо и слизистые оболочки, как правило, не поражаются
- **Морфология элементов:** уртикарии, папулы, бляшки; элементы склонны к сливанию, что может создавать картину, сходную с крапивницей; везикулы и пузыри не характерны (их наличие указывает на пемфигоид беременных)
- **Зуд:** выраженный, усиливается в вечернее и ночное время
- **Системные проявления:** отсутствуют; общее состояние беременной не страдает
- **Прогноз:** благоприятный; спонтанное разрешение в течение 1–2 недель после родов; рецидивы при последующих беременностях редки



PUPPP: характерная сыпь в области растяжек на животе; уртикарии и папулы, сливающиеся в бляшки.

Дифференциальная диагностика: отличие от крапивницы — постоянная локализация на животе, длительное существование элементов, ассоциация с беременностью. Отличие от пемфигоида беременных — отсутствие пузырей, начало в III триместре, благоприятный прогноз.

Лечение: местные кортикостероиды, антигистаминные препараты для облегчения зуда. Системные кортикостероиды не требуются. Госпитализация не нужна при удовлетворительном состоянии матери и плода.



PUPPP: распространённая сыпь на животе и бёдрах; характерное расположение в области растяжек.

Пемфигоид беременных — Pemphigoid gestationis

Редкий аутоиммунный буллёзный дерматоз; распространённость — 1 : 50 000 беременных.

- **Срок возникновения:** преимущественно II триместр; возможен дебют в I триместре или раннем послеродовом периоде
- **Локализация:** начало в периумбиликальной области с последующим распространением на весь живот, затем — на конечности, ладонные и подошвенные поверхности; возможно поражение лица и слизистых оболочек
- **Морфология элементов:** эритема, уртикарии, папулы с последующим формированием пузырей и везикул; элементы имеют тенденцию к группировке
- **Зуд:** интенсивный, часто предшествует появлению сыпи
- **Системные проявления:** возможны слабость, недомогание
- **Прогноз:** риск для плода включает преждевременные роды и гипотрофию; для матери характерны обострения при последующих беременностях; сыпь может персистировать или обостряться в первые месяцы после родов



Пемфигоид беременных: пузыри и везикулы на эритематозном фоне; характерная локализация вокруг пупка.

Дифференциальная диагностика: отличие от PUPPP — наличие пузырей, более раннее начало, риск для плода. Отличие от других буллёзных дерматозов — связь с беременностью, наличие специфических антител.

Лечение: системные кортикостероиды (преднизолон), наблюдение акушером-гинекологом, возможная госпитализация для контроля состояния плода. Местное лечение недостаточно.



Пемфигоид беременных: распространённая сыпь с пузырьками на животе и конечностях; характерное начало вокруг пупка.

Внутрипечёночный холестаз беременных

Состояние, не являющееся дерматозом в строгом смысле, но имеющее важное значение в дифференциальной диагностике зуда при беременности.

- **Срок возникновения:** III триместр
- **Локализация:** сыпь обычно отсутствует; при выраженном зуде возможны эксориации вследствие расчёсывания
- **Клиническая картина:** изолированный зуд без видимой сыпи, усиливающийся в ночное время; возможна желтуха
- **Лабораторные изменения:** повышение уровня желчных кислот, трансаминаз, билирубина
- **Прогноз:** риск для плода включает преждевременные роды и внутриутробную гибель; требуется лечение урсодезоксихолевой кислотой, возможно раннее родоразрешение

Дифференциальная диагностика: отсутствие сыпи при сильном зуде, повышение печёночных проб, связь с беременностью.

Псориаз при беременности

Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи; течение при беременности вариабельно. По данным литературы, у 40–60 % женщин отмечается улучшение кожных проявлений во время беременности, у 10–20 % — обострение, у остальных — стабильное течение.

- **Срок возникновения:** обострения возможны в любом триместре

- **Локализация:** классические локализации включают локтевые и коленные суставы, волосистую часть головы, поясничную область; возможна генерализация процесса
- **Морфология элементов:** эритематозные бляшки с серебристыми чешуйками; характерна псориазная триада (стеариновое пятно, терминальная плёнка, точечное кровотечение)
- **Зуд:** варьируется — от отсутствия до выраженного
- **Прогноз:** для плода, как правило, благоприятный; тяжёлые формы ассоциированы с повышенным риском преждевременных родов и низкой массы тела плода при рождении



Псориаз при беременности: характерные бляшки с серебристыми чешуйками на классических локализациях.

Дифференциальная диагностика: отличие от PUPPP — отсутствие связи с растяжками, наличие чешуек, классические локализации (локти, колени). Отличие от пемфигоида беременных — отсутствие пузырей, хроническое течение до беременности.

Лечение: местные кортикостероиды, эмоленды, при тяжёлых формах — системные препараты (циклоsporин, биологические препараты) по строгим показаниям и под наблюдением специалиста. Требуется консультация дерматолога.

Инфекционные сыпи при беременности

Несмотря на то, что большинство сыпей у беременных — это дерматозы, инфекционную природу нужно исключить в первую очередь.

Краснуха

- **Сыпь:** пятнисто-папулёзная, начинается на лице, распространяется вниз

- **Сопутствующие признаки:** лихорадка, лимфаденопатия (затылочные узлы), конъюнктивит
- **Риск для плода:** высокий в I триместре — врождённые пороки развития
- **Дифференциальная диагностика:** эпидемиологический анамнез, контакт с больными, отсутствие вакцинации



Краснуха: пятнисто-папулёзная сыпь на лице и туловище. Изображение: DermNet (CC BY-NC-ND 3.0 NZ).

Ветряная оспа

- **Сыпь:** везикулёзная, «пёстрая» — пятна, папулы, везикулы, корки одновременно
- **Сопутствующие признаки:** лихорадка, недомогание
- **Риск для плода:** высок риск в I и II триместрах — врождённая ветряная оспа, риск пневмонии у матери
- **Дифференциальная диагностика:** характерная сыпь, контакт с больным, отсутствие вакцинации



Ветряная оспа: везикулёзная сыпь на разных стадиях развития; характерная «пёстрая» картина.
Изображение: DermNet (CC BY-NC-ND 3.0 NZ).

Коклюш

- **Сыпь:** может быть мелкая пятнистая сыпь, но не обязательный признак
- **Сопутствующие признаки:** приступообразный кашель, рвота после кашля
- **Риск для матери и плода:** у матери — осложнения дыхательных путей; для плода — риск преждевременных родов
- **Дифференциальная диагностика:** характерный кашель, эпидемиологический анамнез

Алгоритм догоспитального обследования

Осмотр и сбор анамнеза

1. **Первый вопрос:** когда появилась сыпь, как прогрессировала, что предшествовало появлению
2. **Локализация:** тщательно осмотреть всё тело, включая слизистые
3. **Характер сыпи:** диаскопия, морфология элементов, динамика
4. **Сопутствующие симптомы:** лихорадка, кашель, насморк, боль в горле, артралгии, общее состояние
5. **Акушерский анамнез:** срок беременности, течение беременности, движения плода
6. **Эпидемиологический анамнез:** контакты с инфекционными больными, поездки

Дифференциальные признаки

Признак	Дерматозы беременности	Инфекционные сыпи
Лихорадка	Редко, если есть — обычно субфебрильная	Характерна, нередко высокая
Системные признаки	Отсутствуют или минимальны	Присутствуют (кашель, насморк, слабость)
Локализация	Часто ограничена (живот)	Генерализованная
Динамика	Медленная, постоянная	Быстрая, прогрессирующая
Эпидемиологический анамнез	Отрицательный	Часто положительный
Диаскопия	Бледнеют (сосудистые)	Бледнеют (сосудистые) или нет (геморрагические)

Критерии госпитализации

Обязательная госпитализация требуется при:

1. **Подозрении на инфекционную природу сыпи** с лихорадкой и системными признаками
2. **Тяжёлом состоянии матери** — нарушение гемодинамики, дыхательная недостаточность
3. **Признаках поражения плода** — изменение сердцебиения, уменьшение движений
4. **Подозрении на пемфигоид беременных** — пузыри, быстрое распространение
5. **Подозрении на внутрипечёночный холестаз** — сильный зуд без сыпи, желтуха
6. **Отсутствии возможности наблюдения** — социальные показания

При отказе от госпитализации при удовлетворительном состоянии матери и плода, отсутствии признаков инфекции и характерной картине PUPPP — возможна динамическая оценка на месте с рекомендацией консультации дерматолога и акушера-гинеколога в женской консультации.

Возвращение к клиническому случаю

Сыпь у беременной

Диаскопия показала, что сыпь бледнеет — это сосудистая сыпь, а не геморрагическая. Уже это делает менингококковую инфекцию маловероятной, но инфекцию нужно исключить полностью.

Локализация. Сыпь ограничена животом — конкретно областью растяжек. Ни на конечностях, ни на спине, ни на лице элементов нет. Эта локализация характерна для PUPPP — самого частого специфического дерматоза беременности. Инфекционные сыпи обычно генерализованные.

Характер сыпи. Пятна и папулы, местами сливающиеся в бляшки — типичная картина PUPPP. Нет пузырей, что исключает пемфигоид беременных. Нет везикул, что исключает ветряную оспу. Элементы не возвышаются, как при крапивнице, и длительность их существования — несколько дней, а не часы.

Зуд. Сыпь зудит, что характерно для дерматозов беременности и сосудистых сыпей. При чисто геморрагических сыпях (петехии, пурпура инфекционной природы) зуд отсутствует.

Сопутствующие признаки. Лихорадка была однократная до 38 °С, сейчас температура нормальная. Нет катаральных явлений, нет кашля, насморка, боли в горле — это делает вирусную инфекцию маловероятной. Нет лимфаденопатии, что делает краснуху маловероятной. Нет признаков тяжёлого состояния — пациентка активная, гемодинамика стабильная.

Срок беременности. 33 недели — это III триместр, когда PUPPP возникает наиболее часто. Для пемфигоида беременных более характерно начало во II триместре. Для внутрипечёночного холестаза — III триместр, но обычно нет видимой сыпи, а есть сильный зуд и желтуха.

Эпидемиологический анамнез. Контакт с инфекционными больными отрицательный, поездок не было. Это делает инфекционную природу сыпи маловероятной.

Совокупность признаков — локализация на животе в области растяжек, зуд, сосудистый характер сыпи (бледнеет при диаскопии), отсутствие системных признаков инфекции, срок беременности — указывает на PUPPP. Инфекционная природа маловероятна, но требует исключения из-за риска для плода.

Догоспитальная тактика: полное обследование, диаскопия, сбор анамнеза. При удовлетворительном состоянии матери и плода, отсутствии признаков инфекции, характерной картине PUPPP — возможна динамическая оценка на месте с рекомендацией консультации дерматолога и акушера-гинеколога в женской консультации. При отказе от госпитализации — информировать о рисках, обеспечить возможность наблюдения.

Ответы на вопросы

1. Когда появилась сыпь? Время появления — ключевой фактор дифференциальной диагностики: оно позволяет соотнести сыпь с триместром беременности и отличить дерматозы беременности от инфекционных экзантем.
2. Сыпь на животе у беременной требует исключения специфических дерматозов беременности (PUPPP, пемфигоид беременных) и инфекционных сыпей (краснуха, ветряная оспа). В первую очередь нужно исключить инфекцию из-за риска для плода.
3. PUPPP — самый частый специфический дерматоз беременности, возникает в III триместре, чаще при первой беременности, локализуется на животе в области растяжек, проявляется уртикариями и папулами, зудит, имеет благоприятный прогноз, проходит после родов.
4. Пемфигоид беременных — редкий аутоиммунный дерматоз, возникает во II–III триместрах, начинается вокруг пупка, характеризуется пузырями и везикулами, несёт риск для плода (преждевременные роды, гипотрофия), требует системных кортикостероидов и наблюдения.
5. Псориаз при беременности может улучшаться у 40–60 % женщин, обостряться у 10–20 %. Характеризуется эритематозными бляшками с серебристыми чешуйками на классических локализациях (локти, колени, волосистая часть головы, поясница). Отличается от PUPPP отсутствием связи с растяжками и наличием чешуек, от пемфигоида беременных — отсутствием пузырей и хроническим течением до беременности.
6. Внутрипечёночный холестаз беременных включается в дифференциальный диагноз при сильном зуде без видимой сыпи, может сопровождаться желтухой, несёт риск для плода, требует лечения урсодезоксихолевой кислотой и возможного раннего родоразрешения.
7. Инфекционные сыпи отличают по наличию системных признаков (лихорадка, катаральные явления), эпидемиологическому анамнезу, быстрой динамике, генерализованной локализации. Дерматозы беременности — локализованные, без системных признаков, медленно прогрессирующие.

8. При отказе от госпитализации необходимо оценить состояние матери и плода, исключить инфекцию, обеспечить возможность наблюдения. Обязательная госпитализация — при признаках инфекции, тяжёлом состоянии, подозрении на пемфигоид беременных или холестаз.

Основные выводы

№	Вывод
1	Сыпь на животе у беременной — чаще PUPPP, но сначала исключить инфекцию. Лихорадка, системные признаки, эпидемиологический анамнез в пользу инфекции.
2	PUPPP — III триместр, растяжки, уртикарии, зуд, благоприятный прогноз. Пемфигоид беременных — пузыри, риск для плода, требует кортикостероидов.
3	Псориаз при беременности — может улучшаться или обостряться, бляшки с чешуйками на классических локализациях, обычно благоприятный для плода.
4	Внутрипечёночный холестаз — зуд без сыпи, повышение печёночных проб, риск для плода, требует урсодезоксихолевой кислоты.
5	Инфекционные сыпи исключают по анамнезу, системным признакам, динамике. Краснуха, ветряная оспа несут риск для плода.
6	При подозрении на инфекционную природу сыпи, тяжёлом состоянии матери или признаках поражения плода — обязательная госпитализация. При благоприятной картине PUPPP и отказе от госпитализации — динамическая оценка на месте с рекомендацией консультации дерматолога и акушера-гинеколога.